

Examen blanc Chirurgie n°1 — L3 (Bouaké/Korhogo)

EPREUVE DE CHIRURGIE

EXAMEN BLANC N°1

ANNEE ACADEMIQUE= 2020-2021 DATE = JUILLET 21

DUREE= 1 HEURE 30 min

CIBLE = L3/ IDE

ENSEIGNANT : CELLULE PEDAGOGIQUE

BONNE REPONSE = + 1 POINT ; MAUVAISE REPONSE= - 1 POINT ; PAS DE REPONSE = 0 point

SUJET 1

Une infirmerie privée du quartier "Banaforo" vous a adressé aux urgences chirurgicales du CHR de KORHOGO M.YIEHO NONWA âgé de 26 ans pour :

Douleurs abdominales en << coup de poignard >>

Nausées et vomissements

TA à 90/50 mm Hg

Pouls à 110 battements par minute

Fièvre à 39°5 C

Il présente par ailleurs une anémie et un amaigrissement modéré

Après un examen clinique minutieux, le chirurgien décide de l'opérer dans deux (02) jours. On lui fait les prescriptions suivantes :

La correction de l'anémie par transfusion sanguine

Une réanimation hydroélectrolytique

Une antibiothérapie

Une aspiration digestive

A quelle affection vous font penser ces signes ?

Ulcère gastro-duodéal

Appendicite

Hernie étranglée

Péritonite

Occlusion intestinale aiguë

Choisir deux (02) causes probables parmi celles-ci

Traumatisme fermé de l'abdomen

Ulcère gastroduodéal perforé

Hernie hiatale

Diverticulite du sigmoïde

Quel est le signe fondamental que recherche l'examen physique ?

La paresthésie cutanée

La douleur abdominale constante

L'hyperthermie

La contracture abdominale ou "ventre de bois"

L'anémie

L'hyperleucocytose

Quels sont les soins que vous lui donniez avant l'arrivée du chirurgien ? (Cochez les bonnes réponses)

Administration d'antipyrétique

Administration d'antiémétique

Accueil et installation du malade

Prise des constantes

Lui présenter un haricot en cas de vomissement

Lui dire son diagnostic

Quelles sont les précautions à prendre avant la pose de la poche de sang ? (Cochez les mauvaises réponses)

Envoyer l'Aide-Soignante à la recherche du sang

Vérifier la concordance de la poche de sang avec le sang prescrit

Voir l'aspect du sang

Bien régler le débit de la transfusion

Ne pas faire le test de compatibilité au pied du lit du malade

S'assurer si le malade n'a pas de besoin urgent

Lors de la pose de cette transfusion, vous vous êtes piqué(e) avec l'aiguille non souillée par le sang. Que faites-vous ? Cochez les bonnes réponses

Faire saigner la plaie

Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique et continuer le soin

Informé le Major et Arrêter le soin entrepris

Faire le test de VIH

Demander à l'Aide-Soignant de vous suppléer et vous rentrez chez vous

Ne pas faire une déclaration d'AES chez le médecin référent

Quels sont les éléments de surveillance de l'aspiration digestive ? (Cochez les bonnes réponses)

Surveiller les constantes

Apport liquidien oral pour compenser les pertes liquidiennes

Surveiller l'aspect et la quantité du liquide aspiré

Mobiliser la sonde pour qu'elle n'adhère pas à la paroi gastrique

Contrôler le bon fonctionnement de l'appareillage

Vérifier l'état général du patient

Quels sont les éléments de préparation physique la veille de l'intervention ? (Cochez les mauvaises réponses)

Ne pas faire une toilette complète du malade

Faire un rasage du thorax au pubis

Recouvrir la partie de l'abdomen avec le champ opératoire stérile sans appliquer un antiseptique

Laisser l'Aide-Soignante poser la sonde

S'assurer que le patient est à jeun

Faire la prémédication

Quel est le besoin prioritaire non satisfait ? (Choisir la bonne réponse)

Besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales

Besoin de respirer

Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile

Besoin de communiquer avec ses semblables

Besoin de manger et boire

Besoin de se mouvoir et se maintenir dans une position convenable

M.Konaté Z. est transfusé avec 1740cc de sang total.

Quels sont les méthodes qui permettront de déterminer son groupe sanguin et rhésus ?

Méthode de BED VINCENT

Méthode de SIMON

Méthode de BETH SIMONIN

Méthode de BETH SIMONNE

Méthode de BETH VINCENT

Méthode de SIMONIN

Sachant que les sérums tests AntiA, AntiB, AntiAB et l'AntiD n'agglutinent pas son sang. Quel est le groupe sanguin de M. KONATE Z. ?

O négatif

AB négatif

O positif

AB positif

Calculez le nombre de poches de sang nécessaire sachant que le CNTS ne dispose que des poches de 500 ml.

3 poches

4 poches

5 poches

6 poches

Déterminez le débit d'une poche de sang devant passer en 2 heures et quart ?

193 gouttes/min

194 gouttes/min

55 gouttes/min

56 gouttes/min

42 gouttes/min

72 gouttes/min

SUJET 2

Au CSR de Kagbolokaha, vous recevez en consultation M. Tuo Znapko âgé de 45 ans. Il vous décrit une douleur exacerbée au bas ventre pendant la marche dans le cadran droit de l'abdomen. Après un examen minutieux vous notez :

Conjonctives colorées

Température à 36°9 C

TA= 130/75 mm Hg

Pouls à 80 battements par minute

Petite voussure dans l'aïne

Le reste de l'examen physique est sans particularité

Quel est votre diagnostic ?

Appendicite aigüe

Péritonite localisée

Hernie inguinale

Cholécystite

Quel protocole de traitement préconisez-vous pour M. Tuo Z ?

Accueil et installation

Prise de constantes

surveillance de l'évolution de son état

Mise en observation avec :

Perfusion de sérum glucosé pendant 4heures

Perfusion de paracétamol1g en 15 min

Antibiothérapie injectable

demandeur des examens de confirmation du diagnostic

demandeur à réaliser les examens biologiques

faire les soins préopératoires

administration d'antalgique

procéder à une réduction mécanique par pression externe lente et progressive de la voussure abdominale

faire une fiche de référence pour le centre hospitalier de région

En cas d'intervention chirurgicale, quels sont les signes de contrôle du réveil physiologique du patient ? Cochez les bonnes réponses

- la conscience

- le poids

- la respiration

- le pouls

- la tension artérielle

- le faciès

SUJET N°3

Monsieur OKEHI âgé de 60 ans est hospitalisé en chirurgie pour un adénome de la prostate.

L'examen clinique de monsieur OKEHI menée aux urgences a recherché

Une impériosité mictionnelle

Une matité vésicale

Une pollakiurie

Une hydronéphrose

Des gouttes retardataires d'urines

Une diminution de la force du jet

La liste ci-dessous contient des examens complémentaires de monsieur OKEHI, sauf deux. (Deux éléments de réponse)

Dosage de la PSA

ASP

Créatinine

Echographie rénale

ECBU

Glycosurie

Opéré, la surveillance de monsieur OKEHI comprend les interventions infirmières ci-dessous

Rechercher des signes de caillotages vésicaux

Quantifier les entrées et les sorties

Quantifier la production de la sonde nasogastrique

Maintenir la tête dans l'axe du tronc

Faire une oxygénothérapie quotidiennement

Apprécier le pansement de la plaie opératoire

SUJET N°4

Un brûlé de 50 kg présentant des lésions suintantes hyperalgiques reçoit 4000 ml de solutés le deuxième jour (J2) de réanimation hydro électrolytique.

Les lésions décrites relèvent d'une brûlure de

Premier degré

Deuxième degré superficiel

Deuxième degré profond

Troisième degré

Selon la règle de BAXTER, sa SCB est estimée à

40 %

45 %

50 %

55 %

Le débit des solutés de réanimation le premier jour est d'environ

56 gouttes par minute

111 gouttes par minute

112 gouttes par minute

168 gouttes par minute

Un brûlé à 30% reçoit 5400 ml de soluté en deux (2) jours ; selon la règle de BAXTER, son poids (kg) est de

A- 25 kg

B- 30 kg

C- 35 kg

D- 40 kg

Les interventions infirmières ci-dessous relèvent des soins préopératoires

Préparation psychologique

Prévention thrombo-embolique

Groupe sanguin + Rh

Surveillance et contrôle des drainages

Vérification de la diète alimentaire

Apport nutritionnel par la réanimation

La liste ci-dessous contient trois étiologies d'un abdomen contus. Lesquelles ?

Réplétion intestinale

Occlusion intestinale

Météorisme abdominal

Ascite

Rate paludéenne

Choc abdominal

SUJET N°5

Suite à un accident de la voie publique, vous êtes sollicité à porter secours à LAURENT, victime d'un traumatisme du membre supérieur gauche.

L'examen de Laurent sur le lieu de l'accident révèle une fracture fermée des 2 os de l'avant-bras gauche avec déplacement-

A quel squelette appartient le membre supérieur gauche ?

Axial

Appendiculaire

Zonal

Nommez les os de l'avant-bras gauche

Du dedans en dehors (Radius-Cubitus)

Du dehors en dedans (Cubitus- Radius)

Du dedans en dehors (Cubitus- Radius)

Du dehors en dedans (Radius-Cubitus)

Quelle est votre conduite à tenir en vue d'immobilisation le membre sur le lieu de l'accident ?

Immobilisation provisoire avec une attelle

Immobilisation provisoire avec une gouttière

Immobilisation provisoire avec un morceau de tissu propre

Immobilisation provisoire avec une résine

Immobilisation provisoire avec un plâtre

Donnez les buts de ce soin

Eviter l'aggravation des lésions par la transformation de la fracture fermée en fracture ouverte

Eviter l'atteinte secondaire des vaisseaux ou des nerfs

Diminuer la douleur qui est un facteur de choc

Transformer la fracture fermée en fracture ouverte

Transporter rapidement le blessé à l'hôpital

Avertir les Sapeurs-pompiers rapidement

A l'hôpital, le chirurgien décide la mise en place d'un plâtre. Quel est le nom de ce plâtre ?

Le thoraco-brachial

Le corset plâtré

Le brachio-palmaire

La minerve-plâtrée

Quelle est la complication majeure à redouter devant ce membre plâtré ?

Syndrome de Lyell

Syndrome Loges

Syndrome de Wolkman

Syndrome de Kutchner

Syndrome de Berger

Syndrome de l'Epaulette

Deux jours après l'accident, Laurent signale une douleur abdominale diffuse, constante très intense à l'hypochondre gauche. Il n'arrive plus à faire les selles, il vomit et sa température est à 40°C ; la NFS montre une hyperleucocytose

A quoi pensez-vous ?

Colique néphrétique

Cholécystite aiguë

Crise d'ulcère gastroduodénal

Occlusion intestinale aiguë

Appendicite aiguë

Péritonite

Quel examen physique vous permet de confirmer ce diagnostic ?

L'inspection de l'abdomen

La palpation de l'abdomen à la recherche d'une contracture abdominale

Le transit oeso-gastroduodénal

Le lavement baryté

Bonne Chance à Tous !